

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102895-42.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

**RECORRENTE:** ANA MARIA LOPES VIEIRA

**RECORRENTE:** MARIA LOPES DA SILVA

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). USO OFF LABEL. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO PELO SUS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5102895-42.2024.4.02.5101

510015445432 .V4

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102895-42.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

**RECORRENTE:** ANA MARIA LOPES VIEIRA

**RECORRENTE:** MARIA LOPES DA SILVA

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RELATÓRIO**

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 34ª VF do Rio de Janeiro, em que se pretendia a concessão de tutela para compelir os réus ao fornecimento do medicamento Oxcarbazepina.

Em apertada síntese, a autora narra sofrer de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDHA, necessitando utilizar o medicamento Oxcarbazepina 60mg/ml com urgência, ante a alteração do EEG (funcional do cérebro).

O recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz que a **probabilidade do direito** está amparada nos documentos anexados à inicial, por meios dos quais se comprova: a existência da patologia e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, bem como a omissão do Poder Público para providenciar o fornecimento na via administrativa. Já o **periculum in mora** é justificado porque a não utilização da medicação acarretaria grave comprometimento do bem estar da criança.

Tutela recursal indeferida monocraticamente [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelos recorridos, em que pese devidamente intimados.

É o breve relatório. Decido.

**VOTO**

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

*"Consoante relatado, a demandante é criança portadora de TDHA e pretende obter tutela provisória de urgência, para que as demandadas sejam compelidas a fornecê-la o medicamento **Oxcarbazepina**.*

*A seu turno, o juízo de origem entendeu pelo indeferimento do pedido, pontuando que " a CONITEC não avaliou o medicamento oxcarbazepina para o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade".*

*Os autos foram instruídos com laudo assinado pelo médico assistente, que confirma o diagnóstico e informa a necessidade de administração do medicamento Oxcarbazepina, que possui registro ativo na ANVISA, mas não é dispensado pelo SUS. Indica que a urgência e a imprescindibilidade do uso do fármaco, ante o risco de grave comprometimento do bem estar.*

*A seu turno, o NAT-Jus exara parecer nos autos de origem informando que o medicamento Oxcarbazepina não apresenta indicação em bula no tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Tratando-se, portanto, de uso off label. Destaco:*

*"Referente à indicação da oxcarbazepina, informa-se que o uso do referido medicamento não apresenta indicação em bula<sup>1</sup> no tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Isto significa que o medicamento não está aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o manejo dessa doença, o que caracteriza uso off label.*

*(...)*

*Destaca-se que, até o presente momento, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) não avaliou o medicamento oxcarbazepina para o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH)".*

*Ressalta, ainda, que não existem medicamentos ofertados pelo SUS para tratamento de TDAH, apenas tratamentos não medicamentosos, como terapia cognitiva comportamental:*

*"Acrescenta-se que há o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) publicado pela Ministério da (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS no 14, de 29 de julho de 2022)<sup>6</sup> . Tal PCDT preconiza somente tratamentos não medicamentosos, como terapia cognitiva comportamental (TCC), apoio educacional (ambiente escolar e intervenções escolares), orientação para pacientes, orientações para familiares e hábitos alimentares. Diante o exposto, o SUS não oferta medicamentos para tratamento do TDAH."*

*As políticas públicas na área de saúde não incluem, via de regra, a dispensação gratuita de medicamentos para uso off label, ante expressa vedação do art. 19-T, I, da Lei 8.080/90:*

*Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:*

*I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (...) **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)***

*A vedação não é absoluta, sendo excepcionalmente admitida quando houver **autorização do uso alternativo pela ANVISA**, na forma do art. 21 do Decreto nº 8.077/2013:*

*Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, desde que demonstradas pela Conitec as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido na solicitação.*

*A possibilidade excepcional de fornecimento de fármaco para utilização off label foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça:*

*O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da ANVISA.*

*STJ. 1ª Seção. PUIL 2.101-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/11/2021*

*Não suficiente, com a edição da Lei nº 14.313/2022 foi inserida expressa previsão no art. 19-T, parágrafo único, I, autorizando o fornecimento de medicamento para uso off label, desde que registrado na ANVISA e haja recomendação médica:*

*Art. 19-T. (...)*

*Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)***

*I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas*

sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde; **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)**

Verificada a excepcional possibilidade de uso alternativo ou off label, resta analisar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos elencados no Tema 106 (REsp nº 1.657.156), em recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na espécie, entendo presente o **laudo médico fundamentado**, com indicativo do uso off label da medicação pretendida [evento 1, ANEXO2, fls. 17/21], que apresenta (iii) **registro ativo na ANVISA**.

Todavia, não restou demonstrada a (ii) **incapacidade financeira de custear o tratamento**, porquanto os comprovantes anexos à inicial comprovam renda mensal familiar de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que o medicamento, em posologia suficiente ao tratamento mensal (Oxcarbazepina 60mg/ml) teria custo aproximado de R\$ 67,59 (sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), com possibilidade de valores mais vantajosos no mercado.

Não suficiente, quanto ao **perigo de dano ao resultado útil do processo**, entendo não demonstrado de forma cabal, a ensejar a concessão da tutela em cognição sumária. Isto porque o laudo médico apenas pontua o "comprometimento do bem estar" da parte autora [evento 1, ANEXO2, fl. 20] sem indicar riscos irreversíveis, que não possam aguardar a prolação de decisão final pelo d. juízo de origem.

Por todo o exposto, entendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar **INDEFERIMENTO da tutela recursal**."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se**. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.